

إِسْمُ الْمَرِيضِ رُبَاعِيًّا : رَحْمَهُ حَسَنٌ تَوْفِيقٌ مُصْطَفَى

الحي / المدينة : بولاق الدكرور

المحافظة : الجيزة

رقم البطاقة : 29312112101749 رقم التلفون : 01112394185

العمر(تاريخ الميلاد) : 11-12-1993 المهنة : ربه منزل

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع بأي نظام علاج مثل:- التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-
الهيئات-المؤسسات او أي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة
نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي (-----) التوقيع: (-----)

المقرر بما فيه التوقيع: (-----)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

**قسم العلاج :
الاورام**

خطة العلاج : علاج مبادرة سرطان الثدي علاج كيماوي Anthracyclines base [14151]

التعليق على التشخيص : -----

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد کیلانی

الاسم: د/ندی حسن

الاسم: د/نرمين رمضان

التوقع:

التوقيع:

التوقيع:

تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة و مدير
المستشفى.

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية. كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة في هذا النموذج

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

----- / د ----- / د ----- / د.ا ----- / د.ا

قرار اللجنة

التشخيص النهائي :

خطة العلاج :

المستشفى :

جهة العلاج : --

ملاحظات : ---

ختم

شعار الجمهورية

مدير عام

مديرية الشؤون الصحية

رئیس

المجلس الطبي المتخصص

--

Name: رحمه حسن توفيق مصطفى National ID: 29312112101749	
---	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد أنه
--

المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدي و تحتاج الي Anthracycline-based chemotherapy

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين

Dms
معلومات شخصية



٢٠٢٦/٠٣ ٢٩٣١٢١٢١٠١٧٤٩
 ربة منزل
 انش
 مسجلة
 احمد عباس علي عباس
 البطاقة سارية حتى ٢٠٢٣/٠٣/٠١



جمهورية مصر العربية
 وزارة الداخلية
 بطاقة هوية
 ربة
 حسن توفيق مصطفى
 ه ش نelly مصطفى تاهيا
 بولاق النكر - الجيزة
 ٢٩٣١٢١٢١٠١٧٤٩
 LQ8896329

		مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية	
mm/dd/yyyy			
MDT FORM			
Name: <u>رجمة حسن توفيق محمد علي</u>		MRN: 9852	
Age: 33 Y		ID:	
Menopausal Status: pre		Phone: 01112394185	
NRS SCORE:		Marital Status:	
BMI:		Family History:	
CO Morbidity: free		Reason Of MDT: new	

Clinical Data:

BX: G2 with focal indeterminate DCIS
ER 808 **PR** 8/8 **HER** 2+ nc **KI67** 45

Sonomammography:

Left breast (BIRADS 5): Left UOQ malignant mass lesion and non-mass multifocal lesion as described. For histopathology correlation and CEM study is highly recommended.

Mets Workup:

CT :
Multiple left axillary lymph nodes at level I. ? No pulmonary, hepatic or osseous lesions could be

History:

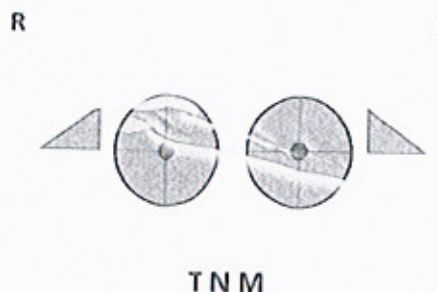
CEM:
LEFT BREAST: UOQ and central (from 11 to 3 o'clock) pathologically enhancing malignant process as above described (BIRADS 6)
RIGHT BREAST: No pathological mass or non-mass enhancement (BIRADS 1).

clinically: LT breast UOQ large mass + (small axillary LNs
T3 N1 M0
for possibility of already tt

Recommendations:

MDT Outcome & Plan

FOR CLIP INSERTION AND BRACKETING FOR TUMOR BEFORE START NEOADJV AC 4 CYCLES THEN TAXOL



SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY	SURGERY	RADIOLOGY	PATHOLOGY	Nutrition	Psychiatric
د. حسن توفيق محمد علي	د. أحمد محمد				

Patient Name : الأستاذ / رحمه حسن توفيق مصطفى

Patient No. : 29312112101749

Path No. : 645/26

Sex : Female

Age : 32 Y

Referring Doc :

Request No. : 13005371

Request Date : 09/03/2026

Verification Date : 18/03/2026

Financial Category : جوسفات روسي - مبادره

Department : Out Patient

Registered by : marwa mohamed youss

Pathology Report

Clinical Data: Left breast mass, "BIRADs 5".

Nature of Specimen: Tru-cut biopsy, collected on 9/3/2026, at 11:22 am, Cold ischemia time: 20 seconds.

Gross Examination:

- Five fragmented grey white tissue cores, ranging in size between 0.5 cm & 1.5 cm long, totally submitted.

Microscopic Examination:

* Histological type: Invasive duct carcinoma.

* Grade 2 (differentiation 3, nuclear pleomorphism 2, mitosis 2).

* Ductal carcinoma in situ: Focal intermediate grade DCIS (Solid & cribriform pattern with comedo necrosis type).

* Perineural invasion: Absent.

* Angiolymphovascular invasion: Absent.

Diagnosis:

- Left breast mass, Tru-cut biopsy:

- Invasive duct carcinoma, Grade 2.

- Focal intermediate grade ductal carcinoma in situ (Solid & cribriform pattern with comedo necrosis type).

- For further IHC (ER, PR, Her2, Ki67).

Signature

Dr. Walaa Ibrahim Ghonaim.

Verified by :

Dr. Duaa Mohamed

Printing Date : 29/03/2026 11:48:14

Page 1 of 2

Printing By : marwa mohamed youss

غرفة رقم (4) - الدور الأول - مبنى رقم (987) - كورنيش النيل - مصر القديمة - القاهرة - مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt

Patient Name : الأستاذ / رحمه حسن توفيق مصطفى

Patient No. : 29312112101749

Path No. : 645/26

Sex : Female

Age : 32 Y

Referring Doc :

Request No. : 13005371

Request Date : 09/03/2026

Verification Date : 18/03/2026

Financial Category : جوستاف رومي - مبادره

Department : Out Patient

Registered by : marwa mohamed youss

Pathology Report

Verified by :

Dr. Duaa Mohamed

Printing Date : 29/03/2026 11:48:14

Page 2 of 2

Printing By : marwa mohamed youss

غرفة رقم (4) - الدور الأول - مبنى رقم (987) - كورنيش النيل - مصر القديمة - القاهرة - مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt

Patient Name : الأستاذ / رحمه حسن توفيق مصطفى
Patient No. : 29312112101749
Path No. : 645/26
Sex : Female
Age : 32 Y
Referring Doc. :

Request No. : 13005371
Request Date : 09/03/2026
Verification Date : 18/03/2026
Financial Category : جوماتف روسي - مبادره
Department : Out Patient
IHC No. :
Registered by : marwa mohamed youssef

IMMUNOHISTOCHEMISTRY REPORT

Clinical Data: Left breast mass, "BIRADs 5" diagnosed Invasive duct carcinoma, Grade 2, with focal intermediate grade ductal carcinoma in situ (Solid & cribriform patterns with comedo necrosis type).

Nature of Specimen: Tru-cut biopsy, collected on 9/3/2026, at 11:22 am, Cold ischemia time: 20 seconds

Technique:

Sections prepared from paraffin block for immune-staining using Bench Mark ULTRA system for; ER clone (1E2), PR clone (SP1), Her2 clone (4B5), Ki67 clone (30-9) & SISH.

Results:

- IHC (All controls showed appropriate reactivity):
- ER: Strong nuclear reaction in 90% of tumor cells (score 8/8).
- PR: Strong nuclear reaction in 95% of tumor cells (score 8/8).
- Her2: Intermediate complete membrane reaction in more than 10% of tumor cells (score 2+).
- SISH: Not amplified.
- (Average Her2 copy No.: (1.75), Her2/CEP17 ratio: (1.52)).
- Ki67%: 45%.

Diagnosis:

Left breast mass, Tru-cut biopsy:

IHC:

- ER: Positive (score 8/8).
- PR: Positive (score 8/8).
- Her2: Equivocal (score 2+).
- SISH: Not amplified, Group V.
- (Average Her2 copy No.: (1.75), Her2/CEP17 ratio: (1.52)).

Verified by :

Dr.Duaa Mohamed

Printing Date : 29/03/2026 11:48:19

Page 1 of 3

Printed By : marwa mohamed youssef

Patient Name الأستاذ / رحمه حسن توفيق مصطفى
Patient No. 29312112101749
Path No. 645/26
Sex Female
Age 32 Y
Referring Doc.

Request No. 13005371
Request Date 09/03/2026
Verification Date 18/03/2026
Financial Category جوستاف روسي - مبادره
Department Out Patient

Registered by .marwa mohamed yousse

IMMUNOHISTOCHEMISTRY REPORT

- Ki67% 45%.

Scoring system: "ER, PR"

ASCO-CAP ER/PR Test Guideline Recommendations: proportion of cells staining (0, no staining; 1, <1%; 2, between 1% and 10%; 3, between 11% and 33%; 4, between 34% and 66% and 5, between 67%-100% of the cells staining). Intensity of positive tumor cells (0, none; 1, weak, 2, intermediate; and 3, strong). Total score from 0 to 8.

Scoring system: "Her2"

Reference: ASCO-CAP Her2 Test Guideline Recommendations. IHC 0 (Null): as defined by no staining observed. IHC 0 (Ultra-low): as defined by membrane staining that is incomplete and is faint/barely perceptible and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 1+: as defined by incomplete membrane staining that is faint/barely perceptible and within > 10% of the invasive tumor cells. IHC 2+ based on circumferential membrane staining that is incomplete and/or weak/moderate and within > 10% of the invasive tumor cells or complete and circumferential membrane staining that is intense and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 3+: based on circumferential membrane staining that is complete, intense > 10% of tumor cells.

ISH groups:

The ratio is calculated and the results is interpreted as:

- Group I (Positive): HER2/CEP17 ratio is more than 2 & Average HER2 copy number/ cell is more than 4.
- Group II (Negative): HER2/CEP17 ratio is more than 2 & Average HER2 copy number/ cell is less than 4. (Recounting give the same result).
- Group III (Positive): HER2/CEP17 ratio is less than 2 & Average HER2 copy number/ cell is more than 6. (Recounting give the same result).
- Group IV (Negative): HER2/CEP17 ratio is less than 2 & Average HER2 copy number/ cell is more than 4 but less than 6. (Recounting give the same result).

Verified by :

Dr. Duaa Mohamed

Printing Date : 29/03/2026 11:48:19

Page 2 of 3

Printed By : .marwa mohamed yousse

غرفة رقم (4) - الدور الأول - مبنى رقم (987) - كورنيش النيل - مصر القديمة - القاهرة - مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt

Patient Name الأستاذة / رحمه حسن توفيق مصطفى
Patient No. 29312112101749
Path No. 645/26
Sex Female
Age 32 Y
Referring Doc.

Request No. 13005371
Request Date 09/03/2026
Verification Date 18/03/2026
Financial Category جوسف روسي - مبادره
Department Out Patient

Registered by .marwa mohamed youssef

IMMUNOHISTOCHEMISTRY REPORT

Group V (Negative): HER2/CEP17 ratio is less than 2 & Average HER2 copy number/ cell is less than

Signature
Dr. Walaa Ebrahim Ghoneim.

Verified by :
Dr. Duaa Mohamed

Printing Date : 29/03/2026 11:48:19

Page 3 of 3

Printed By : .marwa mohamed youssef

غرفة رقم (4) - الدور الأول - مبنى رقم (987) - كورنيش النيل - مصر القديمة - القاهرة - مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt

Patient ID: 93676	Patient Name English: Rahmah Hassan Tawfik
Age: ٣٢ سنة ٢ شهر	2026/03/08 10:35:45 AM : Report Date

Women's Health Outreach Program

Bilateral Full field Digital Mammography and high-resolution ultrasound.

Clinical summary: 33 years old female patient with left breast lump.

Left breast:

- Heterogeneous fibro glandular densities (ACR density c).
- The Left breast shows UOQ a segmental area of asymmetry and distortion with segmental suspicious microcalcifications seen measuring area about 6x4 cm
- Ultrasound revealed a large ill-defined hypoechoic mass lesion with fine internal microcalcifications and internal vascularity within at located at 1 ° clock position about 4 CFMFN and measures about 3x2.5 cm (Index lesion).
- A non-mass heterogeneous area seen from the lesion towards the nipple with query intraductal extension
- Normal nipple/areolar complex.
- Enlarged suspicious looking axillary lymph nodes with increased cortical increased reaching about 7 mm

Right breast:

- Scattered fibro glandular densities (ACR density B).
- No masses, asymmetric densities, distortion or suspicious clusters of micro calcifications.
- Ultrasound demonstrated no solid or cystic lesions.
- Normal skin/subcutaneous tissue and nipple/areolar complex.
- Non-specific axillary LNs.

Impression:

- Left breast (BIRADS 5): Left UOQ malignant mass lesion and non-mass multifocal lesion as described. For histopathology correlation and CESM study is highly recommended.
- Right breast (BIRADS 2): normal study.

*Much obliged,
Dr. Norhan osama MD*